

Vårdprogram stroke

Medicinsk del
Rehabiliterande del

Slutenvård
Blekingesjukhuset

2026-01-01 – 2026-12-31

Förord

Vårdprogrammet för Stroke/TIA gäller för vård på Blekingesjukhuset och är tänkt att vara ett praktiskt stöd för alla medarbetare vilka har kontakt med patienten från inskrivning till utskrivning. Strävan är att formatet ska vara kortfattat och enkelt för att det ska vara ett användarvänligt redskap i vardagen. De som vill fördjupa sig mer i bakgrund, evidens m.m. hänvisas till andra källor exempelvis Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Strokesjukvård och Stroke-up-date.

Vårdprogrammet kommer att revideras och uppdateras årligen under december månad och gäller därefter ett år i taget.

Utarbetad av:

Medicinsk del:

Håkan Johansson, Sektionsansvarig överläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Björn Servin, Överläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Martyna Rosol, Specialistläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Anders Behrens, Specialistläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Katarina Widebrant, Vårdutvecklare Rehabiliterings- och Medicinkliniken
Ann-Charlotte Norén Carlsson, Sjuksköterska Strokeenheten Karlskrona

Rehabiliterande del:

Violeta Stankova-Markova Specialistläkare Rehabmottagning Karlshamn
Jessica Klintö, Arbetsterapeut Arbetsterapi Karlshamn
Tanya Vinterdotter, Dietist Dietistmottagning Karlskrona
Ingrid Elmebris, Kurator Specialistrehab Karlskrona
Franziska Hanewinkel, Logoped Specialistrehab Karlskrona
Maja Pettersson Avdelningschef Arbetsterapi/Sjukgymnastik Karlskrona

Innehåll

Förord	3
Innehåll	4
A. Medicinsk del	7
1. Akut handläggning	7
1.1 Patienter med misstänkt stroke och TIA.....	7
1.1.1 Datortomografi (DT) hjärna	7
1.1.2 Datortomografi hjärna med kontrast (DT angio)	7
1.1.3 Laboratorieprover.....	7
1.1.4 Övrig handläggning	7
1.2 Cerebral blödning	7
1.2.1 Subarachnoidalblödning	7
1.2.2 Intracerebral blödning	8
1.2.3 Akut handläggning av cerebral blödning	8
1.3 Ischemisk stroke/TIA.....	9
1.3.2 Vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla	9
1.3.3 Behandling av expansiv hjärninfarkt.....	10
1.3.4 Blodtryck vid ischemisk stroke.....	10
2. Generellt omhändertagande av samtliga strokepatienter i akutskedet dvs. de första 3 dygnen.....	11
2.1 Cirkulation i övrigt och elektrolytrubbningar.....	11
2.1.1 Förhöjt blodsocker	11
2.1.2 Feber	11
2.1.3 Hypoxi	11
2.2 Trombosprofilax på helt immobiliserade patienter	11
2.3 Krampfall.....	11
2.4 Övervakning/Kontroller	11
2.5 Omhändertagande av patient med sväljningssvårigheter	12
2.6 Obstipationsprofilax på immobiliserade patienter.	12
2.7 Mobilisering, teambedömning och rehabilitering	12
2.8 Övriga resurser.....	12
3. Fortsatt utredning med fokus på bakomliggande orsak till hjärninfarkt/TIA och hjärnblödning samt sekundärprofilax	13
3.1 Undersökningar/provtagningar	13
3.1.1 Carotisundersökning	13
3.1.2 Diagnostik av förmaksflimmer	13
3.1.3 Ekokardiografi.....	13
3.1.4 Magnetresonanstomografi (MRT)	13

3.2 Utvidgad utredning hos yngre patienter med stroke (18–55 år)	13
3.2.1 Ovanliga diagnoser	14
3.3 Cerebral blödning	14
3.4 Differentialdiagnoser	14
3.4.1 Neurologiska sjukdomar	14
3.4.2 Icke neurologiska sjukdomar	14
3.5 Sekundärprofylax	15
3.6 Behandling vid vissa specifika tillstånd	15
3.6.1 Kärldissektion	15
3.6.2 Sinustrombos	15
3.6.3 Vid hjärninfarkt och tidigare genomgången hjärnblödning	15
4. Uppföljning/Utskrivning	16
B. Rehabiliterande del	17
1. Inneliggande Rehabilitering	18
1.1 Förutsättningar för inneliggande rehabilitering	18
1.2. Kontraindicerade faktorer för inneliggande rehabilitering	19
2. Arbetsterapeut	20
2.1 Bedömning	20
2.2 Insatser	20
3. Sjukgymnast/Fysioterapeut	22
3.1 Bedömning	22
3.2 Insatser	22
4. Logoped	24
4.1 Bedömning	24
4.2 Behandling	25
5. Dietist	26
5.1 Bedömning	26
5.2 Insatser	26
Nutritionsbehandling	26
6. Kurator	27
6.1 Socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete	27
6.2. Utredning och bedömning av vårdbehov utifrån ett psykosocialt perspektiv	27
7. Sexolog	28
Appendix I	29
Utdrag ur Riksstrokes diagnoslathund	29
Appendix II	30

Appendix III	32
ABCD2-score	32

A. Medicinsk del

1. Akut handläggning

1.1 Patienter med misstänkt stroke och TIA

- Plötsligt insättande fokala neurologiska bortfall.
- Om insjuknande i stroke inom 24 timmar. Se Rädda hjärnan – PM.

1.1.1 Datortomografi (DT) hjärna

- Akut (oberoende av tid på dygnet)
- TIA med endast amaurosis fugax är dock **inte** indikation för akut DT hjärna.

1.1.2 Datortomografi hjärna med kontrast (DT angio)

- I normalfallet. Patienter med njursvikt, multisjuklighet och stort ADL-behov kan undantas.

OBS! Strokepatienter skall med högsta prioritet inläggas på strokeenhet!

1.1.3 Laboratorieprover

- Rädda hjärnan-patient: Se Rädda hjärnan-PM.
- Övriga stroke/TIA patienter: Ankomstprover vid misstänkt stroke/TIA; PK, APTT, blodsocker, blodstatus, CRP, elstatus, Hba1c, kreatinin, blodfetter inklusive LDL, leverstatus.

Komplettera vid behov de blodprover som redan är tagna på t.ex. akutmottagningen.

1.1.4 Övrig handläggning

- EKG (på akuten/avdelningen)
- Carotisultraljud om DT angio inte är gjort och om patienten är bedömd som möjlig op-kandidat.
- Inled sekundärprofylax

1.2 Cerebral blödning

1.2.1 Subarachnoidalblödning

- Åskknallshuvudvärk
- Syncope eller medvetandepåverkan möjligt debutsymtom.
- DT hjärna inom 6 timmar från debut säkert diagnostiskt enligt Socialstyrelsen (SoS). OBS! Säker debuttid. Patienten får inte ha andra neurologiska symtom än huvudvärk, normalt nervstatus (inkl. ögonbottenundersökning). Granskning utförs av läkare med neuroradiologisk kompetens.
- Om inte ovanstående föreligger och DT hjärna är utan anmärkning utförs LP med spektrofotometri tidigast 12 timmar efter debut.
- Vid positivt fynd direkt kontakt med Neurokirurgen (NK) i Lund.

1.2.2 Intracerebral blödning

- Hematom ökar i storlek under det första dygnet i en stor andel av fallen.
- Handläggningen baseras på individuell bedömning av prognos. Vakna patienter med små supratentoriella intracerebrala blödningar (<20–30 ml) har god prognos. Patienter med blödningar >110 ml, medellinjeöverskjutning >10 mm, hög ålder och/eller djup medvetlöshet har dålig prognos oavsett åtgärd.

1.2.3 Akut handläggning av cerebral blödning

- a) Reversering av antikoagulantia
- b) Blodtrycksbehandling
- c) Kan operation vara aktuell?
- d) Vårdsnivå?

a) Antikoagulantibehandlad patient

OBS! Vid behov konsultera koagulationsjouren i Malmö!

Antidotbehandling bör inledas <30 min.

- Warfarinbehandling (konsultera koagulationsjouren akut!)
 - Koncentrat av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (för närvarande Ocplex) så snabbt som möjligt efter det att blödning konstaterats till fall som inte initialt är djupt medvetandesänkta. Behandling med färskfrusen plasma utgör andrahandsalternativ.
 - Till alla patienter ges dessutom K-vitamin (Konakion 10 mg i.v.).
- NOAK-behandling
 - Ge antidot om tillgängligt (Endast Praxbind till Pradaxa tillgängligt för närvarande; -finns på IVA).
- Lågmolekylärt heparin
 - Individuell bedömning. Konsult enligt ovan.
 - Vid trombocythämmande behandling finns ingen vedertagen antidot, endast seponering av läkemedel.

b) Blodtrycksbehandling vid blödning

- Akut blodtrycksbehandling till systoliskt blodtryck (SBP) 130-140mmHg rekommenderas i nuläget. Målnivå inom 30 min. men maxsänkning 60mmHg första timmen. Lämpliga läkemedel; Trandate, Furix, Catapresan, Enap.
- Vid subarachnoidalblödning systoliskt blodtryck <160mmHg hos vuxen, vaken patient.
- Vid i.v. blodtrycksbehandling ska patienten vara uppkopplad på övervakningsutrustning. Om svårreglerat blodtryck; - täta blodtryckskontroller varje kvart tills blodtrycket är stabilt till uppnått målblodtryck inom 30 min.

c) Vårdsnivå

Lägg in/transportera patienten till lämplig vårdenhet; intensivvård, neurokirurgisk vårdenhet eller strokeenhet. Undvik förhastade beslut i de fall patienten hade ett självständigt liv före insjuknandet. Vissa patienter med medvetandesänkning kan behöva IVA-vård i akutskedet. Vårdsnivå på sikt kan avgöras senare.

d) Neurokirurgi?

- **Cerebellär blödning.** Tidig kirurgi kan vara aktuell. Snabb försämring kan ske pga. hjärnstamskompression eller sekundär hydrocefalus; - en frisk storhjärna kan räddas. Neurokirurg (NK)kontakt på vid/bred indikation och eventuellt övertag för bättre operationsberedskap. Blödning >3 cm och progress är oftast operationsindikation. (OBS! motsvarande för infarkt).
- **Storhjärnsblödning.** "Mellanstora" hematom, framför allt inom 1 cm från hjärnytan och påverkan på medvetandegrad, kan vara aktuella för operation. Hematomvolym >100 ml mycket dålig prognos oavsett åtgärd. Generellt för gruppen finns ingen vinst med neurokirurgisk behandling och neurokirurg behöver endast kontaktas i utvalda fall, t.ex. vid ytligt hematom enligt ovan eller medvetandepåverkad operabel patient.

1.3 Ischemisk stroke/TIA

1.3.1 Akutbehandling av TIA och hjärninfarkt

- **Rädda hjärnan-patient** – Se särskilt PM i Rädda hjärnan-mappen.
- **Trombocythämmare** - Rutinbehandling i de allra flesta fall!
 - Oavsett patogenetisk mekanism; Acetylsalicylsyra (ASA) 300 mg ges direkt efter DT hjärna följt av 75 mg dagligen. Ansvarig sjuksköterska kontakter ansvarig läkare efter DT-svaret. Efter trombolys ges ASA först efter kontroll-DT av hjärnan.
 - Mild hjärninfarkt (NIHSS ≤3) och vid "högrisk-TIA" (4–7 poäng på riskskalan för TIA, ABCD 2, se appendix III), ges dubbel trombocythämning med laddningsdos från insjuknandedagen till och med dag 21.
 - Patienter som redan behandlas med annan trombocythämmare än ASA; oförändrad trombocythämmande behandling under första dygnet.
 - Vid amaurosis fugax kan behandlingen inledas utan föregående datortomografi (DT).
 - Om patienten inte kan svälja eller är medvetandesänkt ge supp. Acetylsalicylsyra (ASA) 130 mg x2 i laddningsdos följt av 130 mg dagligen.
 - Vid intolerans mot ASA ges Clopidogrel laddningsdos 300 mg följt av 75 mg dagligen.

1.3.2 Vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla

- Antikoagulantia kan sättas in på TIA-patienter under första dygnet.
- Kontroll-DT efter 1 vecka vid större hjärninfarkt och därefter ställningstagande till insättning av antikoagulantia.
- NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) rekommenderas i första hand.
- Patienter som redan behandlas med antikoagulantia; överväg tillfällig seponering (speciellt vid lillhjärnsinfarkt eller stor hemisfärfarkt).

1.3.3 Behandling av expansiv hjärninfarkt

- Vid expansiv mediainfarkt kan hemikranektomi vara aktuell.
OBS! Kontakt med neurokirurg under 1: a dygnet. Oftast något yngre patient, expansiva fynd på DT-hjärna och medvetandepåverkan.
- Vid expansiv lillhjärnsinfarkt kan dekompressionskirurgi övervägas.

1.3.4 Blodtryck vid ischemisk stroke

- Akut behandling endast vid blodtryck >230/130 mmHg efter observation under 2 timmar på vårdavdelningen. Helst peroral behandling. Ges i gängse doser.
- Sätt ej ut patientens ordinarie blodtryckssänkande behandling (i synnerhet betablockerare) om inte BT <130/80 under första dygnet.
- Blodtrycket rekommenderas att hållas över 130 mmHg speciellt om avancerad arterioscleros och vid misstanke om perfusionsrelaterade symtom.

2. Generellt omhändertagande av samtliga strokepatienter i akutskedet dvs. de första 3 dygnen

2.1 Cirkulation i övrigt och elektrolytrubbningar

- **OBS!** Viktigt att optimera systemfaktorer för att minimera risken för att den ischemiska randzonen (penumbran) omvandlas till infarkt och blir permanent. Första dygnen efter stroke kan vara avgörande för utbredningen av penumbrazonen.
- Undvik dehydrering! Snabbt ställningstagande till behovet av i.v. vätska! Ge Ringer-Acetat v.b. de två första vårddygnen (undvik glucoslösningar).

2.1.1 Förhöjt blodsocker

- Normoglukemi eftersträvas. Nivåer upp till 15 mmol/l accepteras. Behandling enligt gängse principer.

2.1.2 Feber

- Vid $>37,5^{\circ}\text{C}$; ge Paracetamol 1 gram.
- Vid $>38^{\circ}\text{C}$; Ta CRP, LPK och urinsticka. (Om ej redan taget det senaste dygnet.)

2.1.3 Hypoxi

- Fria luftvägar, eventuellt nästub.
- Ge syrgas vid hypoxi; vid saturation $<94\%$ ges syrgas på gramma eller öppen mask 2–4 lit/min v.b.
- Vid kronisk hypoxi (saturation $<90\%$) och kronisk koldioxidretention (KOL) kontaktas läkare för vidare ordination.

2.2 Trombosprofilax på helt immobiliserade patienter

- Lågmolekylärt heparin i profilaxdos sätts in dag 2 vid hjärninfarkt.
- Vid hjärnblödning kan lågmolekylärt heparin övervägas efter några dygn om tillståndet är stabilt.

2.3 Krampanfall

- Vid upprepade anfall under akutskedet är det indicerat med en kortare tids anfallsbehandling. Levetiracetam kan vara en lämplig behandling för i.v. och peroralt bruk.

2.4 Övervakning/Kontroller

- Strokekontroller enligt övervakningsschema - se Appendix II, är obligatoriskt. Dessa görs första vårddygnet var 4:e timme, om ej annat ordineras. OBS! rektal temp (kärntemperatur) och manuella blodtryckskontroller. Vid Rädda hjärnan-larm och Actilyse-behandling se separat PM.
- Tättare eller fortsatta strokekontroller enligt läkarordination på patienter med blödning eller infarkt i bakre skallgropen samt malign mediainfarkt. Risk för snabb symtomutveckling och kontroller minst varannan timme, speciellt av medvetandet.
- EKG dag 1 samt dag 2 vid hjärninfarkt och TIA.

- Ankomstprover stroke (CRP, B-Blodstatus, B-Retikulocyter, B-Leukocyter, maskindiff, elstatus, kreatinin, leverstatus, P-glucos, blodfetter, PK, APT-tid, Hba1C) tas vid ankomst. Ej kompletta ankomstprover (t. ex från akutmottagningen) kompletteras senast dagen efter. Vid Rädda hjärnan-larm och Actilyse-behandling; Se separat PM.
- Längd, vikt & BMI senast dagen efter ankomst. (BMI >25 är en oberoende riskfaktor.)
- Blodtryckskontroll x1/dag efter avslutade strokekontroller tills stabilt enligt målnivå. I övrigt enligt ordination.
- Tempkontroll x1/dag efter avslutade strokekontroller på sängliggande patienter, samt vid feber x 2/dag.

2.5 Omhändertagande av patient med sväljningssvårigheter

- Strokeobservation inklusive sväljningstest med vatten tsk-vis utförs av van avdelningspersonal för att pröva patientens sväljningsförmåga enligt anvisning på baksidan av strokekontrollistan (se Appendix II). Se även PM - "Sväljscreening slutenvård" Blekingesjukhuset. OBS! Risk för aspiration. Ev. behov av konsistens-anpassad kost och dryck alternativt 0 per os. Logoped kontakts för bedömning.
- Om patienten är medvetslös och inte kan medverka till sväljningstestning sätts Ringer-Acetat i.v. omgående, efter ordination av läkare. Vidare sväljningsbedömning av logoped när det är möjligt.
- Vätskebehandling med Ringer-Acetat kan ges de första två dygnen. Om inte behandlingen övergår i en rent palliativ fas påbörjas därefter nutrition via nasogastrisk sond. Om detta inte är möjligt får TPN övervägas.
- Om inte sväljningssvårigheterna verkar övergående ställningstagande till PEG i samråd med logoped.

2.6 Obstipationsprofylax på immobiliserade patienter.

- Tillräckligt med vätska och ev. anpassad kost
- Överväg bulkmedel (t. ex Vi-Siblin, Inolaxol) eller osmotiskt verkande preparat (t. ex Forlax, Laktulos) enligt ordination om patienten kan svälja.

2.7 Mobilisering, teambedömning och rehabilitering

- Mobilisering påbörjas omgående utifrån patientens förutsättningar.
- Sängläge endast medvetandesänkta patienter.
- OBS! Fallrisk på grund av medicinska skäl. Se PM Fallprevention. Förflyttningshjälpmedel vid behov.
- Teambedömning av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut samt ev. logoped så fort som möjligt med bedömning av funktionsförmåga, ev. rehabpotential samt behov av ev. hjälpmedel och träning.
- Efter det akuta vårdförloppet överväg och ta upp på pulsronden (multidisciplinär) om patienten kan vara aktuell för SPRIH eller slutenvårdsrehabilitering.

2.8 Övriga resurser

- Kurator
- Dietist

3. Fortsatt utredning med fokus på bakomliggande orsak till hjärninfarkt/TIA och hjärnblödning samt sekundärprofylax

3.1 Undersökningar/provtagningar

3.1.1 Carotisundersökning

- Indikation:
 - Alla patienter med TIA eller lindrig hjärninfarkt inom carotisterritoriet som potentiellt kan bli föremål för carotiskirurgi.
- DT-angio bör utföras snarast inom 2 dygn (48 timmar).
- Ultraljud preoperativt eller vid oklart CT angio-fynd.
- Carotisoperation skall ske skyndsamt, senast inom 2 veckor.

3.1.2 Diagnostik av förmaksflimmer

- Remiss till thoraxkliniken för 48 tim långtidsEKG-registrering (LTER);
 - Diagnos ischemisk stroke eller TIA där orsaken är okänd.
 - Inget tidigare känt förmaksflimmer.
 - Bedöms vara kandidat för antikoagulantibehandling om förmaksflimmer diagnostiseras.

3.1.3 Ekokardiografi

- Indikation:
 - Hjärninfarkt eller TIA om fynd av kardiell embolikälla i det enskilda fallet påverkar behandlingen (t.ex. antikoagulantibehandling, endokardit-behandling).
 - Rutin hos unga (<60 år) om annan orsak till stroke inte framkommit.
- Indikationen mindre stark vid annan misstänkt huvudmekanism (t.ex. signifikant carotisstenos påvisad vid duplexundersökning).
- Indikationen bortfaller vid kroniskt förmaksflimmer.
- Ej rutin hos patienter äldre än 60 år och utan tecken på hjärtsjukdom.

3.1.4 Magnetresonanstomografi (MRT)

- Kan vara indicerad vid oklar diagnos i synnerhet i bakre skallgropen där DT-diagnostik är svårare.
- Vid differentialdiagnostiska problem, t.ex. misstanke på multipel skleros.
- För diagnostik av sinustrombos, extrakraniell dissektion, intracerebralt hematoma (senare än 2 veckor efter insjuknandet).
- Diffusions-MRT kan vara av värde för differentialdiagnostik och för att påvisa en akut infarkts läge och storlek.

3.2 Utvidgad utredning hos yngre patienter med stroke (18–55 år)

- DT-angiografi från arcus och upp.
- MRT hjärna
- Kontrastförstärkt ekokardiografi

- LTER i 72 timmar
- Koagulationsutredning
- Esofagusekokardiografi endast i utvalda fall. Behövs ej vid PFO-utredning.
- Överväg vidare utredning; vanlig orsak är tidig förekomst av kärlriskfaktorer eller kärldissektion.

3.2.1 Ovanliga diagnoser

- Sinustrombos
- Paradoxal embolism
- Fabrys sjukdom
- Antikardiolipinsyndrom
- Vaskulit

3.3 Cerebral blödning

- Kartlägg bakomliggande orsak;
 - Småkärlssjuka
 - Amyloid angiopati
 - Blödning i tumör
 - Kärlmissbildning

3.4 Differentialdiagnoser

Vanlig felkälla är tidigare stroke eller annan hjärnsjukdom med försämring av symptom vid t.ex. infektion eller annan allmänpåverkan t.ex. dehydrering.

3.4.1 Neurologiska sjukdomar

- Epilepsi;
 - Partiell epilepsi som i sin tur kan bero på till exempel hjärntumör eller kärlmissbildning.
 - Postapoplektisk epilepsi bör alltid övervägas om patienten drabbas av nya neurologiska symptom motsvarande det tidigare drabbade området.
- Intrakraniell expansivitet
- Herpesencephalit
- Skov av demyeliniserande sjukdom
- Migrän (inklusive retinal migrän)

3.4.2 Icke neurologiska sjukdomar

- Metabola störningar och allmänna infektionssjukdomar, feber, hypo- eller hyperglykemi, elektrolytrubbningar, intoxikationer med mera.
- Temporalisarterit
- Ögonsjukdomar
- Öronsjukdomar
- Funktionella symptom

3.5 Sekundärprofylax

- ASA-behandling från akutskedet fortsätter vanligtvis som sekundärprofylax. Vid ASA-allergi används i stället Clopidogrel. Vid fynd av förmaksflimmer eller annan potent kardiell embolikälla; NOAK behandling.
- Vid mild ischemisk stroke med NIHSS ≤ 3 eller högrisk-TIA ges dubbel trombocythämning med 75 mg Clopidogrel och 75 mg ASA till dag 21. Därefter endast ASA. Laddningsdos från start.
- Blodtrycket behandlas efter akutskedet enligt gängse riktlinjer.
- Statinbehandling rutinmässigt till alla där dosen anpassas efter LDL-nivån med målsättning att LDL ska vara under 1.8 $\mu\text{kat/L}$. Patienter med dålig prognos får bedömas individuellt.
- Carotiskirurgi vid symtomgivande tät stenosis och operabel patient. Vid carotisstenosis $>50\%$ (enligt NASCET) kan operation bli aktuell. Inför eventuell operation skall neurologkonsult i Karlskrona alternativt ansvarig överläkare på avd. 58 kontaktas. Denne bedömer patienten och sköter vid behov vidare kontakt med kärlkirurg.
- Individuell noggrann genomgång av övriga riskfaktorer, till exempel fysisk inaktivitet, BMI >25 och rökning. OBS! Tänk på att kontakta sjukgymnast vid låg fysisk aktivitet.
- Vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla tidigt insatt AK-behandling.

3.6 Behandling vid vissa specifika tillstånd

3.6.1 Kärldissektion

Standard är ASA-behandling alternativt Clopidogrel. Vid speciellt hotfulla situationer kan antikoagulantibehandling och kärlintervention övervägas.

3.6.2 Sinustrombos

Standard är lågmolekylärt heparin/antikoagulantia även om det finns en sekundär parenkymbloodning. Utredning krävs av bakomliggande orsak. Vid svåra fall kan lokal trombolys vara aktuell.

3.6.3 Vid hjärnfarkt och tidigare genomgången hjärnblödning

Vid exempelvis tidigare genomgången hypertoniobloodning med aktuellt välkontrollerat blodtryck kan ASA eller AK övervägas efter individuellt ställningstagande.

Slutning av vänster förmaksöra (s.k. förmaksplugg) är möjlig, men betraktas av Socialstyrelsen som åtgärd inom FoU enligt riktlinjer för stroke 2017.

4. Uppföljning/Utskrivning

Vid utskrivning från strokeenheten får patienten ett utskrivningsmeddelande och läkemedelslista. Vid hjärninfarkt/hjärnblödning gäller förbud att framföra motorfordon i minimum 3 månader, gällande yrkeschaufförer i minimum 6 månader. Efter TIA gäller alltid 1 månads förbud att framföra motorfordon.

Ställningstagande till vapenlicens vid vapeninnehav.

Uppföljning av stroke och TIA sker i primärvården vilka skall tillsändas remiss. Av remissen skall framgå individanpassade konkreta mål med uppföljningen. I enstaka fall kan uppföljning på neurologmottagningen vara motiverat, exempelvis vid ovanliga strokemekanismer, yngre patienter eller icke färdig medicinsk utredning.

Råd till primärvården + länk till SKL;

<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/beslutsstod-korkort-efter-stroke-tia.html>

Gällande korrekt diagnossättning; – Se Appendix I ”Utdrag från Riksstroke diagnoslathund”

För komplett lathund var god se;

<http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2018/01/Riksstroke-diagnos-lathund-reviderad-nov-2017.pdf>

När patienter har vårdats på annan enhet än strokeenhet är det viktigt att respektive strokeenhet meddelas för möjlighet till registrering i det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

B. Rehabiliterande del

Rehabilitering efter stroke är nödvändigt för att återfå eller förbättra kroppsfunktioner. I Sverige får de flesta sin rehabilitering utanför akutsjukhuset. I Region Blekinge erbjuds teambaserad rehabilitering i både slutenvård och öppenvård beroende på patientens funktionsnedsättningar. Ett multiprofessionellt team träffar patienter på strokeenheten i samband med inskrivning eller då det medicinska tillståndet tillåter det, bedömer patientens funktionsnedsättningar och erbjuder tidiga rehabiliteringsinsatser.

Teambaserad intensiv strokerehabilitering i slutenvård är en patientcentrerad process med flera professioner involverade för att stötta den enskilda individen. I teamet ingår läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, rehab. undersköterska, logoped, kurator, sjuksköterska och undersköterska. Innehållet i rehabiliteringen ska vara individanpassat och målinriktat utifrån patientens önskemål och behov. Denna vårdform tillämpas främst på patienter med måttlig - svår stroke och stort rehabiliteringsbehov som inte bedöms kunna genomföras i andra former för rehabilitering och har visat ha en bättre effekt på funktions- och aktivitetsförmåga, jämfört med andra former av rehabilitering. En förutsättning är att rehabiliterings-potential finns, vilket innebär att patienten vill och kan medverka vid träning samt orkar genomföra slutenvårdens intensiva träning.

Vid lindrig till måttlig stroke utan betydande kognitiva nedsättningar kan en alternativ rehabilitering i tidig fas erbjudas som innebär tidigare hemgång från sjukhus med fortsatt rehabilitering i hemmet. Denna rehabilitering ges eller koordineras då av ett specialutbildat interdisciplinärt rehabiliteringsteam som förkortas SPRIH (Specialiserad rehabilitering i hemmet). Se vårdprogrammet för SPRIH. Även här är rehabiliteringen individanpassad och målinriktad. Åtgärden minskar risken för död och ADL-beroende och medför en kortare initial vårdtid samt innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med sedvanlig vård på strokeenhet.

Individanpassad och målinriktad rehabilitering kan erbjudas även i öppenvårdsregi för personer med lindrig stroke eller personer som har genomfört rehabilitering i slutenvård eller i hemmet. I dessa fall anses den fortsatta rehabiliteringen leda till ökad självständighet och delaktighet i det vardagliga livet, understödja arbetsåtergång, minska behov av kommunala resurser och förbättra personens livskvalitet.

Förbättringar av patientens fysiska och kognitiva funktioner fortsätter även flera år efter att en stroke har inträffat, beroende på individens förutsättningar, det vill säga avvikelsegrad i kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt faciliterande och hindrande faktorer hos individen och omgivningen. Bedömning av behov av rehabiliteringsinsatser i slutenvård – eller öppenvård kan därför vara aktuell även i senare skede, om ovan nämnda förutsättningar förändras, även om patienten initialt inte har kunnat fullfölja ett rehabiliteringsprogram.

1. Inneliggande Rehabilitering

Rehabiliteringsenheten är en specialistvårdsenhet, som i första hand främjar särskilda rehabiliterande insatser snarare än internmedicinska och kirurgiska insatser eller omvårdnadsinsatser. Rehabilitering definieras som insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, med hänsyn till helhetsperspektiv utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Ett rehabiliteringsprogram för inne-liggande rehabilitering omfattar minst tre (3) timmars rehabiliteringsinsatser per patient dagligen med hjälp av ett koordinerat interdisciplinärt team. Dessa insatser kan omfatta sjukgymnastik/fysioterapi, arbetsterapi, talterapi, kognitiv terapi, neuropsykologiska insatser, mobilisering m.fl.

Inneliggande rehabilitering rekommenderas när patientens hälsotillstånd är sådant att andra enheter rimligen inte kan erbjuda de intensiva rehabiliteringsinsatser som krävs. I Region Blekinge finns 1 strokeenhet där tidiga rehabiliteringsinsatser ges och det finns nära samarbete kring det akuta skedet och fortsatt rehabilitering.

1.1 Förutsättningar för inneliggande rehabilitering

Inneliggande rehabilitering är medicinskt nödvändig när följande förutsättningar föreligger:

1. Individen har drabbats av en stroke som har resulterat i en betydande försämring av funktionsförmågan så att det inte är tillräckligt för att återhämta sig i en mindre intensiv miljö;
2. Individens övergripande hälsotillstånd och medicinska behov talar för en risk för medicinsk instabilitet eller ett behov av läkare och annan sjukvårdspersonal som inte är tillgänglig utanför slutenvårdsmiljön;
3. Individen behöver ett intensivt interdisciplinärt, samordnat rehabiliteringsprogram med minst tre (3) timmars aktivt deltagande dagligen;
4. Individen är medicinskt stabil så att det inte längre krävs medicinska/kirurgiska slutenvårdsinsatser;
5. Individen är i stånd till att aktivt delta i ett rehabiliteringsprogram, vilket kräver respons till verbala, visuella och/eller taktila stimuli samt förmåga att följa enkla kommandon.
6. Individens mentala och fysiska tillstånd innan insjuknande/skada indikerar att det finns en betydande potential för förbättringar;
7. Individen förväntas visa mätbara funktionella förbättringar inom högst sju (7) till fjorton (14) dagar (beroende på underliggande diagnos/sjukdom) från inskrivningen på rehabiliteringsavdelningen;
8. Rehabiliteringen omfattar en utskrivningsplan.

1.2. Kontraindicerade faktorer för inneliggande rehabilitering

En annan form av rehabilitering utanför sjukhuset eller inneliggande vård bör erbjudas när en eller flera av följande faktorer föreligger:

1. **Oförmåga att delta:** Patienten kan inte tolerera 3 timmars behandling per dag.
2. **Ovilja att delta:** Patienten vill inte delta i fysioterapi/arbetsterapi/talterapi och/eller visar inga tecken på eller bristande motivation i tidigare försök att utföra terapi
3. **Nedsatt rehabiliteringspotential:** Patientens aktuella funktionella status bedöms vara väldigt nedsatt och förväntas inte förbättras av inneliggande rehabiliteringsinsatser eller denne är för närvarande inte annorlunda än sin habituella baslinje (bekräftat av tidigare historia, journaler, eller tillförlitlig källa).
4. **Demens:** Patienten har en kronisk kognitiv svikt som inte förväntas förbättras och gör rehabiliteringsförsök osannolikt eller omöjligt.
5. **Behöver inte hjälp från åtminstone 2 olika paramedicinare:** Patienten måste visa nyttan av att arbeta med åtminstone två av dessa: sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped.
6. **Akut sjukdom eller tillstånd:** Patienten har en akut sjukdom/tillstånd som kräver medicinsk intervention före överföring till en rehabiliteringsavdelning - dessa inkluderar:
 - a. sepsis (infektion med feber och förhöjda infektionsparametrar)
 - b. delirium (medicinuflöst, uttorkning, infektionssjukdomar, förgiftning)
 - c. instabila vitala parametrar (allvarlig hyper- eller hypotension, allvarliga arytmier, hypoxi trots syretillskott)
 - d. akut psykotisk episod (inklusive aktiva hallucinationer eller vanföreställningar)
 - e. okontrollerad smärta (patientens smärta kontrolleras inte tillräckligt för att möjliggöra deltagande i terapi)
 - f. svår anemi
 - g. extrem trötthet eller slöhet på grund av sjukdom
7. **Pågående utredning eller kommande operativa åtgärder:** Patienten är under utredning för DVT, hjärtrubbning, stroke, infektion, anemi, bröstsmärta, blödning, etc. eller är på väg att genomgå en intervention (operation, radiologisk undersökning, labbtest) som kan påverka differentialdiagnos eller det omedelbara förloppet av patientens medicinska/kirurgiska status.

2. Arbetsterapeut

2.1 Bedömning

Arbetsterapeuten på strokeenheten träffar patienten snarast efter det att denne blivit inlagd på strokeenheten. Så snart patientens allmäntillstånd tillåter (ofta redan första vardagen efter inläggning) påbörjas ADL – bedömning (Karlshamn) respektive bedside-bedömning (Karlskrona) tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut. Fortsatta bedömningar görs därefter vid behov;

- Anamnes och bedömning av nuvarande aktivitetsförmåga och aktivitetsutförande gällande ADL-aktiviteter inom personlig vård, boende, utbildning/arbete och fritid. Bedömning av aktivitetsförmågan sker med stöd av strukturerade observationer, standardiserade tester samt skapande aktiviteter. Aktivitetsutförandet analyseras utifrån motoriska och kognitiva aspekter.
- Handstatus med standardiserade tester samt i praktisk aktivitet. Bedömning görs av rörelseförmåga, handstyrka (Jamar/Grippit), känsel (monofilament), finmotorik (pinnprov/Purdue Pegboard) samt greppförmåga.
- Bedömning av kognitiv förmåga görs via strukturerade observationer i aktivitet och/eller via kognitiva papper/penna uppgifter till exempel Cognistat, AMPS, DBF, RBMT, klocktestet, Alberts test, pokalen.
- Bedömning av hemmiljön görs vid hembesök från rehab. avdelningen eller vid intervju för ställningstagande till behov av hjälpmedel/bostadsanpassning inför permission/utskrivning. Hembesök görs tillsammans med patienten och eventuell anhörig, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut från avdelningen samt arbetsterapeut i hemsjukvården. Hembesöket syftar även till att bedöma patientens aktivitetsförmåga i sin hemmiljö och för att kartlägga vad hon/han behöver träna på återstående tid av rehabiliteringsvistelsen.

2.2 Insatser

Träning på arbetsterapin och/eller på avdelningen sker alla vardagar för varje patient där behov finns och anpassas efter patientens aktivitetsnivå och behov av träning.

- **Träning i aktivitet** syftar till att förbättra dels den motoriska, dels den kognitiva förmågan. Det kan till exempel vara aktiviteter inom personlig vård som tränas på vård-avdelningen. Det kan även vara aktiviteter för att underlätta det egna boendet eller aktiviteter inriktade mot fritid.
- **Funktionsträning** utförs gällande motorik och kognition för att förbättra ADL-förmågan. Exempel på funktionsträning som kan genomföras är individuell hand-/arm träning, stå-träning, träning av koncentration, uppmärksamhet eller problemlösning genom olika papper/penna uppgifter eller genom hantverks-aktiviteter.

- **Kompensatorisk träning** handlar om att träna inre och yttre strategier i form av förändrat utförande eller utprovning/träning av tekniska hjälpmedel.
- **Hjälpmedelsförskrivning** Arbetsterapeuten provar ut och förskriver individuella hjälpmedel som patienten behöver på avdelningen eller i samband med permission/utskrivning. Förskrivning av hjälpmedel till hemmet görs även av och i samråd med arbetsterapeuten i hemsjukvården.

I den gemensamma rehabiliteringsplanen förnyas aktivitets- och funktionsdelmål efter hand vid möten med patient, övriga paramedicinare samt vid ronder. Tidig kontakt tas med ansvarig arbetsterapeut i hemsjukvård/kommun för att förbereda inför hembesök och permissioner.

Arbetsterapeuten tillsammans med övriga i teamet strävar mot en god samverkan med anhöriga, vilket sker kontinuerligt under vårdtiden. Anhöriga erbjuds delta vid behandling/träning, i samband med teamsamtal informeras anhöriga om träningen och det görs även en planering framåt som de är delaktiga i.

I samband med utskrivning överrapporteras patient vid behov till arbetsterapeut i kommunen, till specialistrehabiliteringen, specialiserad rehabilitering i hemmet (SPRIH) eller till primärvården.

Sista fasen av rehabiliteringen kan i vissa fall ske i patientens hemmiljö. Rehabiliteringsansvaret tas då över av SPRIH-teamet (Specialiserad rehabilitering i hemmet). SPRIH-teamet består av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och rehab. undersköterska. Till teamet finns även knutet läkare, logoped, kurator och sjuksköterska. Var god se vårdprogrammet för SPRIH!

3. Sjukgymnast/Fysioterapeut

3.1 Bedömning

Sjukgymnasten/fysioterapeuten på strokeenheten träffar patienten snarast efter det att denne blivit inlagd på strokeenheten eller så snart patientens tillstånd tillåter, ofta redan första vardagen efter inläggning. (I Karlskrona görs bedside-bedömning tillsammans med arbetsterapeut. I Karlshamn görs en neurologisk bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut).

Den sjukgymnastiska/fysioterapeutiska bedömningen utförs enligt följande:

Anamnes: för att fastställa patientens tidigare funktionsstatus och nytillkomna problem/svårigheter inom rörelseförmåga, förflyttning, gångförmåga, balans, ADL och eventuella hjälpmedel.

Status: för att fastställa patientens aktuella funktionsstatus samt identifiera problem/svårigheter inom följande områden:

- Förflyttning: förflyttning i säng, från säng till stol. Förmåga att gå inne, ute och i trappa. Hur mycket medverkar patienten? Finns behov av hjälpmedel?
- Selektiv motorik: övre extremitet och nedre extremitet. Grov kraft och funktionell rörlighet (Motor Assessment Scale M-MAS UAS -99).
- Balans: i sittande och stående, statisk och dynamisk. Föreligger fallrisk? Bergs Balansskala, Timed Up and Go – TUG, 10 meter gångtest, 6 minuter gångtest.
- Sensibilitet: ytlig och djup känsel, taktil gnosis.
- Andning/cirkulation: föreligger slemretention? Finns risk för komplikationer?
- Koordination: diadokokinesi, reciproka rörelser, finger-näs, hæl-knä.
- Smärta; VAS
- Kognition: orientering x 3, hur tar patienten instruktioner? Har patienten insikt om sina problem?
- Muskeltonus: graderas enligt Ashworth-skalan. Risk för kontrakturer?
- Perception, synfält
- Kommunikation
- Motivation

3.2 Insatser

Bedömning och träning sker dagligen på vardagar.

Träningen är schemalagd och sker antingen på avdelningen eller på sjukgymnastiken. Gymnastiksal och träningsbassäng finns också tillgänglig och ibland sker träning utomhus.

Den initiala träningen går ut på att klara av korta förflyttningar, hitta balansen i sittande samt bedömning av komplikationsrisker. Därefter övergår man till att träna längre förflyttningar och gång. Träning av patientens förflyttnings- och gångförmåga

sker delvis tillsammans med omvårdnadspersonalen. Vid behov hålls en speciell förflyttningsgenomgång med berörd personal. Patientens förflyttningsförmåga rapporteras kontinuerligt. Hjälpmedel för att underlätta vid förflyttning och gång finns på avdelningen. Sjukgymnasten/fysioterapeuten ombesörjer förskrivning av bland annat gånghjälpmedel.

Stor vikt läggs vid balans- styrke-, koordinations- konditions- och andningsträning samt kontrakturprofylax. Stimulering till aktivitet på den svaga sidan tillämpas kontinuerligt. Den sjukgymnastiska/fysioterapeutiska träningen inriktar sig på att förbättra motoriska färdigheter och bibehålla det som finns.

Parallellt observeras och tränas kontinuerligt patientens kognitiva funktioner som förmågan att ta initiativ och förstå instruktioner samt träning av koncentration och minne.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten medverkar i:

- Teamsamtal: informationsmöte för patient och närstående med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, logoped, kurator och sjuksköterska. Se Dokument; "Teamsamtal".
- Hembesök: allt eftersom rehabiliteringen fortskrider kommer patienten att tillbringa mer tid i hemmet. Som en förberedelse för detta gör arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut från rehab. avdelningen hembesök tillsammans med patienten för att bedöma patientens aktivitetsförmåga i sin hemmiljö och för att kartlägga vad hon/han behöver träna på återstående tid av rehabiliteringsvistelsen. Hembesöket syftar även till att undersöka eventuellt behov av bostadsanpassning och/eller hjälpinsatser i hemmet. Se Dokument "Hembesök".

Sjukgymnasten/fysioterapeuten medverkar även när det gäller:

- Sekundärprofylax gällande fall och frakturer, skuldersmärta, spasticitet, kontrakturer och pneumoni.
- Planering inför hemgång
- SPRIH

Sista fasen av den ineliggande rehabiliteringen kan i vissa fall ske i patientens hemmiljö. Rehabiliteringsansvaret tas då över av SPRIH-teamet (Specialiserad rehabilitering i hemmet). SPRIH-teamet består av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och rehab. undersköterska. Till teamet finns även knutet läkare, logoped, kurator och sjuksköterska.

Vid utskrivning överrapporteras patienten vid behov till sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen, primärvården eller för specialistrehabilitering. Se separat vårdprogram.

4. Logoped

4.1 Bedömning

Logopedisk bedömning sker vid behov på initiativ av övriga medlemmar i stroke-teamet /sjuksköterska eller läkare på avdelningen. Vid hjärnskada kan såväl språk, tal och sväljning påverkas på olika sätt. Diagnoserna afasi, dysartri respektive dysfagi sätts vid svårigheter. Ibland föreligger nedsättning av flera förmågor samtidigt. Korrekt differentialdiagnostik mellan afasi och dysartri är viktig.

Bedömning görs av:

- Språk/afasi (hörförståelse, läsförmåga, muntlig uttrycksförmåga och skrivförmåga) med t ex Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning (GNU) afasidelen, Neurolingvistisk Afasiundersökning (A-ning) eller föremål/bilder/text.
- Tal/dysartri (talandning, röstbildning, oralmotorik, nasalitet, artikulation, prosodi och förståelighet) med t ex Dysartritest H&S.
- Sväljning/dysfagi (inspektion oralt, munmotorisk screening och självobservation av valda konsistenser). Klinisk sväljbedömning görs vid behov efter en första måltidsobservation eller screening utförd av vårdpersonal. Vid ätobservation under patientens första måltid provas lämplig konsistens ut. Vid svårigheter skall logoped kontaktas. Resultatet av ätobservationen skall dokumenteras i både omvårdnadsstatus samt i en omvårdnadsanteckning under sökordet nutrition. I samråd med vårdpersonal och läkare avgörs om nutriering per os är lämplig/möjlig. Vid stora, komplicerade eller kvarstående svårigheter kan instrumentell bedömning göras. Remiss skickas då av logoped eller läkare i samråd till röntgen för Terapeutisk sväljningsröntgen med logoped respektive ÖNH-läkare för Fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS).

4.2 Behandling

Logopedisk behandling sker på olika plan för att:

- Förbättra funktionerna (till exempel läs- och skrivträning, mun- och talträning, sväljträning)
- Lära in kompensation för att klara olika aktiviteter som rör språk, tal och sväljning (till exempel samtala med konkret stöd, öva in strategier vid ordsökning, läsning och skrivning, anpassa taltempo, använda hjälpmedel, träna in sväljtekniker, konsistensanpassa).
- Underlätta social delaktighet (till exempel uppmuntra och stötta patienten, ge närstående och personal information och råd hur underlätta kommunikation, optimera intag av mat och dryck tillsammans med andra).

5. Dietist

5.1 Bedömning

Bedömning av nutritionsstatus görs tidigt i sjukdomsförloppet och upprepas med jämna tidsintervall med samtidig regelbunden viktuppföljning 1–2 gånger/vecka. Dietist bör kontaktas för konsultation vid behov. Behandlingen måste utformas individuellt och följas upp och utvärderas regelbundet. Val av lämplig form av nutritionsbehandling avgörs av tugg- och sväljförmåga samt bedömt behov av i första hand energi och protein.

5.2 Insatser

Nutritionsbehandling

Kostbehandling

Kostbehandling bygger på kost i hel eller anpassad konsistens. Personer med nedsatt aptit bör erbjudas energi- och proteinrik kost.

När det inte är möjligt att täcka beräknat behov av energi- och näringsämnen med kostbehandling, måste medicinsk nutritionsbehandling övervägas, antingen som enda näringskälla eller i kombination med kostbehandling.

Medicinsk nutritionsbehandling

För val och dosering av kosttillägg bör samråd ske med dietist som kan göra en Individuell bedömning av typ och mängd utifrån patientens behov.

Enteral näringstillförsel är att föredra framför parenteral näringstillförsel, så länge absorptionen i tarmen fungerar. Vid övergående dysfagi rekommenderas naso-gastrisk sond men vid långvariga eller bestående svårigheter rekommenderas PEG. För val och dosering av sondnäring bör samråd ske med dietist som kan göra en individuell bedömning av typ och mängd utifrån patientens behov.

6. Kurator

6.1 Socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete

Kuratorsn arbete inriktar sig på sociala och psykosociala problem.

Utifrån patientens och/eller närstående behov träffas en överenskommelse om fortsatt kuratorskontakt.

Kontakten med kurator kan innefattas av:

- Samtalsbehandling- att ge psykologiskt stöd till patient och/eller närstående – exempelvis krissamtal, stödsamtal, bearbetande samtal och motivationssamtal. Vid fördjupat behov av samtalsstöd till närstående rekommenderas kontakt med primärvården.
- Social information och rådgivning. Information om samhällets resurser vid sjukdom avseende exempelvis omvårdnad, ekonomi, utformande av fullmakt, godmanskäp, arbete och rehabilitering.
- Hjälp i kontakten med myndigheter eller andra vårdgivare för initiering av insatser, hjälp med ansökningar och stöd vid kontakt med exempelvis arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggare.

6.2. Utredning och bedömning av vårdbehov utifrån ett psykosocialt perspektiv

Kuratorn medverkar vid teamrönder och pulsönder. En första bedömning görs då om kuratorskontakt bör initieras. I vissa fall kan inte dessa mötestillfällen inväntas, exempelvis vid misstanke om krisreaktioner, oro/ångest, nedstämdhet/depression. Kuratorn kontaktas då direkt av annan vårdpersonal. Även närstående erbjuds kontakt vid behov.

Vid en mer omfattande kontakt tas anamnes med inriktning på det psykosociala området; familjesituation, bostad, ekonomi, arbete, skola/utbildning, fritid, socialt nätverk/stöd-belastning, psykosocial bakgrund, funktionsförmåga, behandlingskontakter, myndighetskontakter, aktuell psykisk och social problematik. Utifrån anamnes görs sedan en bedömning av behov av kuratorsåtgärder.

7. Sexolog

Arbetet med sexuell hälsa sker på olika nivåer utifrån PLISSIT-modellen (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy). Det innebär att all personal utifrån egna förutsättningar skall kunna möta sexuella frågeställningar. Vid behov av ytterligare insatser kan patienter hänvisas till sexologerna på kliniken som är placerade i Karlshamn. Patienterna kan ta kontakt via egenremiss eller via internremiss under vårdtillfället.

Behandlingen kan vara terapeutiskt inriktade samtal, råd och stöd. Insatser, som till exempel farmakologisk behandling, sker i samverkan med läkaren och vid behov med andra team-medlemmar. Informationsbroschyr om sexuell hälsa finns i väntrum och patientpärm.

Appendix I

Utdrag ur Riksstrokes diagnoslathund

För komplett lathund var god se;

<http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2018/01/Riksstroke-diagnos-lathund-reviderad-nov-2017.pdf>

1. AKUT STROKE

Subarachnoidalblödning **I60**

Intracerebralblödning **I61**

Observera: Intracerebral blödning ska vara verifierad med bilddiagnostik eller obduktion. Endast patienter med nytillkommen blödning i relation till det aktuella vårdtillfället får denna diagnoskod. För tidigare stroke – se nedan, under punkt 4. Vid traumatiska blödningar – se nedan, under punkt 8.

Cerebral infarkt **I63**

Storkärlssjukdom I63.0

Småkärlssjukdom (lakunär) I63.3

Kardioembolisk stroke I63.4

Ospecificerad okänd orsak I63.9

Stroke ej specificerad som blödning eller infarkt **I64.9**

Observera: Används om klinisk strokebild föreligger men bilddiagnostik eller obduktion ej har gjorts.

TIA **G45**

Vertebralis G45.0

Carotis G45.1

Amaurosis fugax G45.3

UNS G45.9

Observera: Diagnosen TIA används vid fokala symtom som kvarstår mindre än 24 timmar och som är nytillkomna. Om strokesymtomen försvinner fullständigt efter trombolys och ingen strokemimic misstänks ges också diagnosen TIA och används även om bilddiagnostik påvisat färsk lesion

4. TIDIGARE STROKE ELLER TIA

Tidigare subarachnoidalblödning **med** sequelae I69.0

Tidigare intracerebral blödning **med** sequelae I69.1

Tidigare cerebral infarkt **med** sequelae I69.3

Tidigare stroke **med** sequelae I69.4

Tidigare stroke **utan** sequelae Z86.7C

Tidigare TIA Z86.6A

Observera: Riksstroke rekommenderar att I69/Z86 vid behov används som bidiagnos när patienter som tidigare haft en stroke respektive TIA rehospitaliseras utan att ha en ny stroke-/TIA-händelse, oavsett om inläggningen sker inom 12 månader från det ursprungliga insjuknandet eller ej. Patienter med diagnos I69/Z86 registreras inte i Riksstroke.

8. TRAUMATISKA HJÄRNBLÖDNINGAR

Traumatisk hjärnblödning S06.3

Traumatisk epiduralblödning S06.4

Traumatisk subduralblödning S06.5

Traumatisk subarachnoidalblödning S06.6

Observera: Vid S06 används även orsakskod (skadans yttre orsak). Traumatiska hjärnblödningar ingår inte i definitionen av stroke och registreras inte i Riksstroke.

Strokekontroller



Appendix II

Namn och födelsedata

Datum: _____

Kontroll 1	Kontroll 2	Kontroll 3	Kontroll 4	Kontroll 5	Kontroll 6
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Klockslag för kontroll: (Var 4:e tim, första vård dygnet.)					
Medvetandegrad enl. ACVPU-skalan V.g. se baksidan.					
Blodtryck (manuellt)					
Puls					
Saturation (Om <94% ge syrgas 2-4 lit./minut enl. vårdprogram stroke.)					
Temperatur OBS! Rektaltemp! (Vid >37,5°C ge Paracetamol 1 gram. Vid >38°C ta även CRP, LPK samt urinsticka enl. vårdprogram stroke.)					
Blodsocker (Fortsatta kontroller endast om >6,5 mmol/l.)					
Bladderscan (Fortsatta kontroller om res. urin >200 ml.) (Ev. RIK/KAD om res. urin >400 ml (på läkarordination enl. PM))					

Tal

0= Utan anmärkning					
1= Sluddrigt tal					
2= Avvikande tal (t.ex. svårt att hitta ord)					
3= Talar ej					
Förståelse (lyder uppmaning) Ja/Nej (Be t.ex. pat. öppna/sluta ögonen.)					

Pares arm Börja med den icke paretiska armen. Be pat. lyfta (ev. hjälp upp) armen i 45° vinkel mot sängen med handflatan nedåt. Kryssa för svagaste sidan: Vä ☐ Hö ☐

0= Håller kvar svagaste armen i minst 10 sek.					
1= Armen sjunker inom 10 sek men når inte sängen.					
2= Armen sjunker till sängen inom 10 sek men pat. försöker hålla emot tyngdkraften.					
3= Armen faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkraften. Pat rör armen mot underlaget.					
4= Ingen rörlighet i armen.					

Pares fingrar Be pat. sträcka ut sina fingrar så mycket som möjligt. Kryssa för svagaste sidan: Vä ☐ Hö ☐

0= Normalt (ingen flexion/böjning inom 5 sek)					
1= Flexion/böjning inom 5 sek men kvarvarande sträckförmåga.					
2= Ingen viljemässig extension/sträckning kvar i 5 sek.					

Pares ben Börja med det icke paretiska benet. Be pat. lyfta (ev. hjälp upp) ett ben i taget i 30° vinkel mot sängen. Kryssa för svagaste sidan: Vä ☐ Hö ☐

0= Håller kvar svagaste benet i minst 5 sek.					
1= Benet sjunker inom 5 sek men når inte sängen.					
2= Benet faller till sängen inom 5 sek men pat. försöker hålla emot tyngdkraften.					
3= Benet faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkraften. Pat rör benet mot underlaget.					
4= Ingen rörlighet i benet.					

Facialis pares: Ja/Nej Be pat. le och visa tänderna. Kryssa för sidan m. pares: Vä ☐ Hö ☐

Neglect/Synfältsbortfall: Ja/Nej Be pat. ange om dina fingrar syns eller inte i respektive yttre synfält. Vid neglect/bortfall: kryssa för vilken sida: Vä ☐ Hö ☐

Sväljningssvårigheter: Ja/Nej Prova med 1 tsk vatten till vaken pat. V.g. se sväljningstest/flödesschema på baksidan.

Signatur

Rev. 241210/acnc

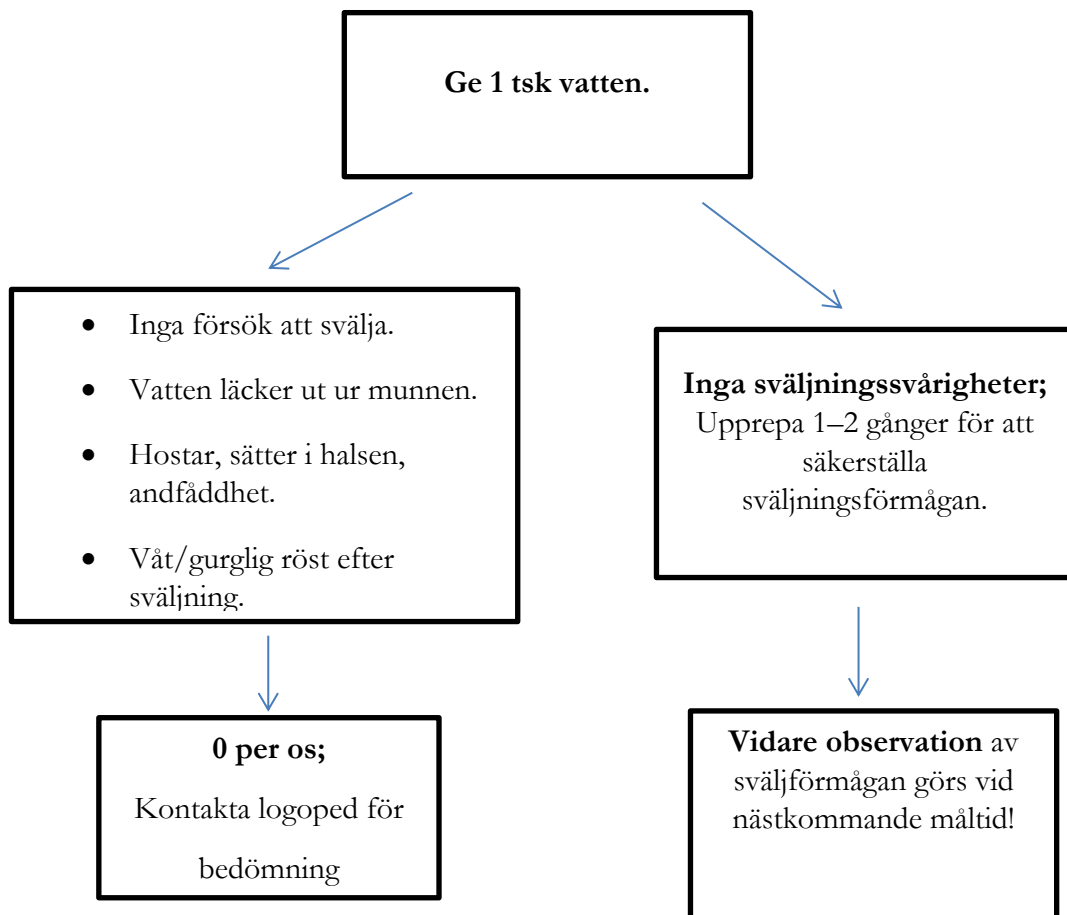
Övrig information: _____

OBS! Utförda strokekontroller, inklusive ev. övrig information, ska dokumenteras i patientens journal.

Medvetandegrad enl. ACVPU-skalan

A (Alert)	Vaken och alert. (RLS 1)
C (Confusion)	Nytilkommen eller förvärrad förvirring. (RLS 2–3)
V (Voice)	Slö. Reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop. (RLS 2)
P (Pain)	Mycket slö. Reagerar vid smärtstimulering. (RLS 3)
U (Unresponsive)	Okontaktbar. Reagerar ej vid tilltal eller smärtstimulering. Ev. stereotypa böj- eller sträckrörelser eller ingen reaktion alls. (RLS 4–8)

Sväljningstest till vaken patient



Appendix III

ABCD2-score

Assessment of severity of transient ischaemic attack and minor stroke and subsequent risk of stroke

Transient ischaemic attack

- Severity assessed by ABCD2 score:
 - *Age*—1 point if ≥ 60 years
 - *Blood pressure*—1 point if $\geq 140/90$ mm Hg
 - *Clinically*—1 point if speech disturbance only, 2 points if unilateral weakness
 - *Duration*—1 point if 10 minutes to 1 hour, 2 points if ≥ 1 hour
 - *Diabetes*—1 point if present
- Subsequent risk of stroke based on ABCD2 score:
 - Score 1-3 (low)=1.2% at 7 days
 - Score 4-5 (moderate)=5.9% at 7 days
 - Score 6-7 (high)=11.7% at 7 days